

TEMA 3.46 • OBSTETRICIA

Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI

PERFIL EUNACOM 1.03.46
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI

Parámetros del MEFI

1. Frecuencia Cardíaca Fetal Basal

Normal: 110–160 lpm

- < 110 = bradicardia
- > 160 = taquicardia
- Mientras más alejado del rango normal, mayor riesgo

2. Variabilidad

Amplitud de oscilación de la línea de base.

TABLA 3.46.1: VARIABILIDAD VS AMPLITUD		
VARIABILIDAD	AMPLITUD	SIGNIFICADO
Ausente	0 lpm	Muy mal pronóstico
Mínima / disminuida	< 5 lpm	Signo de alarma
Moderada (normal)	5–25 lpm	Óptima
Aumentada	> 25 lpm	Sospechoso

NOTA CLÍNICA
La variabilidad **no incluye** aceleraciones ni desaceleraciones.

3. Aceleraciones

Normales → signo de bienestar fetal.

4. Desaceleraciones

TABLA 3.46.2: TIPO VS NOMBRE				
TIPO	NOMBRE	MECANISMO	RELACIÓN CON CONTRACCIÓN	SIGNIFICADO
Dip 1	Precoz	Compresión cabeza fetal (vagal)	En espejo (simultánea)	Normal
Dip 2	Tardía	Hipoxia fetal	Decalaje (aparece después, >15-20 seg)	Patológico
Variables	Variable	Compresión cordón umbilical	Variable	Intermedio (sospechoso)

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Las variables tienen morfología en "joroba de camello" (aceleración → desaceleración → aceleración).

5. Patrón Sinusoidal

El más grave. Patrón premortem. Indica interrumpir de inmediato.

Clasificación del MEFI

TABLA 3.46.3: CATEGORÍA VS CRITERIOS		
CATEGORÍA	CRITERIOS	NOMBRE
MEFI-1	FCF basal normal + variabilidad moderada ± aceleraciones ± dip 1	Tranquilizador
MEFI-2	No es 1 ni 3	Sospechoso
MEFI-3	Patrón sinusoidal O variabilidad mínima/ausente + (dip 2 recurrentes O variables recurrentes O bradicardia)	Anormal / Ominoso

NOTA CLÍNICA

MEFI-2 clásicos: taquicardia aislada, bradicardia aislada, alteración de variabilidad aislada, dip 2 o variables **sin** alteración de variabilidad.
MEFI-3: requiere variabilidad mínima/ausente **más** al menos una de las tres alteraciones (o patrón sinusoidal).

Manejo

MEFI-1

Conducta expectante. Tacto vaginal para evaluar condiciones obstétricas del parto.

MEFI-2 y MEFI-3

Reanimación intrauterina (mismas 3 medidas para ambos):

- Oxígeno** a la madre
- Decúbito lateral izquierdo** (o derecho)
- Suspender goteo oxitócico**

→ Si no mejora en **30 minutos** → **interrumpir por la vía más expedita**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
Bradicardia sostenida: FCF < 100 lpm por ≥ 10 minutos → **interrumpir por la vía más expedita directamente** (no se espera ni se reanima).

Vía Más Expedita — Cómo Determinarla

Se determina con el **tacto vaginal**:

CONDICIÓN	VÍA
Cefálica + dilatación completa (10 cm) + 3er plano de Hodge (espinas +2)	Fórceps
No cumple condiciones para fórceps	Cesárea de urgencia (en 5 minutos)

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Indicaciones de interrumpir por la vía más expedita: 1. MEFI-2 que no mejora tras 30 min de reanimación 2. MEFI-3 que no mejora tras 30 min de reanimación 3. Bradicardia sostenida (< 100 lpm x ≥ 10 min) → directo sin reanimar

Casos Prácticos

TABLA 3.46.5: HALLAZGO VS CLASIFICACIÓN

HALLAZGO	CLASIFICACIÓN	CONDUCTA
Basal 150 + variabilidad ausente + dip 2	MEFI-3	Reanimar → si no mejora en 30 min → vía más expedita
Basal 150 + variabilidad aumentada + 1 dip 2 aislada	MEFI-2	Reanimar → evaluar en 30 min
Basal 180 (taquicardia) + variabilidad normal	MEFI-2	Reanimar → evaluar en 30 min
Basal 120 + variabilidad disminuida, sin desaceleraciones	MEFI-2	Reanimar → evaluar en 30 min
Basal 130 + variabilidad normal + aceleraciones + sin desaceleraciones	MEFI-1	Conducta expectante
Basal normal + dip 1 (en espejo)	MEFI-1	Conducta expectante

Basal 90 × 10 min (bradicardia sostenida) | **Bradicardia sostenida**
 Interrumpir vía más expedita directamente |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI: Frecuencia Cardíaca Fetal Basal Normal: 110–160 lpm - < 110 = bradicardia - > ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Parámetros del MEFI
- 1. Frecuencia Cardíaca Fetal Basal
- 2. Variabilidad
- 3. Aceleraciones
- 4. Desaceleraciones
- 5. Patrón Sinusoidal
- Clasificación del MEFI

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DETECCIÓN DE HIPOXIA FETAL INTRAPARTO — MEFI)

PREGUNTA 1

En relación a Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI: Frecuencia Cardíaca Fetal Basal Normal: 110–160 lpm - < 110 = bradicardia - > ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Detección de Hipoxia Fetal Intraparto — MEFI. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: DETECCIÓN DE HIPOXIA FETAL INTRAPARTO — MEFI

:::tip Las variables tienen morfología en "joroba de camello" (aceleración → desaceleración → aceleración). :::
 :::note MEFI-2 clásicos: taquicardia aislada, bradicardia aislada, alteración de variabilidad aislada, dip 2 o variables sin alteración de variabilidad. MEFI-3: requiere variabilidad mínima/ausente más al menos una de las tres alteraciones (o patrón sinusoidal). :::